

소속, 성명: 급여등재실 □부 E 팀장, F 과장

제 목: 필수의료분야 기술 신속 등재를 통한 국민체감 보장성 확대

내 용

1. 추진배경

- 건강보험에 요양급여대상 또는 비급여 대상으로 결정되지 아니한 행위는 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제10조에 따라 요양기관 등이 신의료기술의 안전성·유효성 등 평가결과 고시 이후 가입자 등에게 최초로 실시한 날부터 30일 이내 보건복지부 장관에게 요양급여대상여부를 결정신청해야하며, 경제성 및 급여적정성 등에 대하여 △전문평가위원회의 평가를 거쳐 요양급여대상여부를 결정하고 있다.
- 우리부는 '정부정책'과 발맞추어 신의료기술 결정신청 건 중 국민 생명과 직결되는 **필수 의료분야**(중증질환 및 취약계층 대상) 행위를 우선 검토하여 국민의 의료 안전망 강화에 기여하고자 하였다.

2. 추진내용

- 국민·의료계 요구도 높은 **필수의료분야 우선 등재**
 - '22년에는 필수적인 의료분야인 신생아, 소아 및 사회적 취약계층 대상의 신의료기술을 검토하여 국민 접근성을 향상시켰다.
 - 신생아 대상의 리소좀축적병 선별검사는 선천성 희귀질환을 조기에 진단하는 검사로 리소좀축적병 의심환자, 가족력이 있는 환자 뿐만 아니라 모든 신생

아에게 하는 검사로 적응증을 확대하였다. ('22년도 6차 행전위)

- 또한, 소아심장수술 후 필수치료인 ‘일산화질소 흡입 치료’에 대해 관련 진료과인 소아과와 여러 차례 자문회의를 통해 신생아를 대상으로 급여기준을 마련하였고(보건복지부 고시 제2020-330호, 2021.1.1. 시행), **추가적으로 소아를 대상으로 요양급여범위를 확대**(보건복지부 고시 제2022-283호, 2023.1.1. 시행) 하였다.
- 더불어, 우측 내경정맥이나 쇄골하정맥을 통해 접근이 불가능하거나 혈관의 협착으로 상지에 더 이상 투석 접근로를 형성할 수 없는 혈액투석이 필요한 신부전 환자에게 **혈액투석 접근통로를 조성시키기 위해 회소·긴급 치료재료***를 **사용토록 하는 행위인 ‘혈액투석 도관삽입을 위한 역방향의 중심정맥 재개통술’** (보건복지부 고시 제2022-217호, 2022.10.1. 시행), ‘말기 신부전 환자를 위한 인조혈관-중심정맥도관 결합 혈액투석 접근통로 조성술’ (보건복지부 고시 제2022-236호, 2022.11.1.시행).을 신속하게 검토하여 요양급여대상으로 등재하였다.

※ 관련 치료재료: 회소·긴급 치료재료_혈액투석 도관 삽입을 위한 역방향의 중심정맥 재개통술용 CATHETER, 인조혈관-중심정맥도관 결합 혈액투석 접근통로 조성술용 인조혈관

3. 추진성과

- 국민 생명과 직결 가능한 의료분야 우선 등재로 인해 30만 신생아·소아의 건강권 보장 및 국민의료비 약 217억* 절감을 추정하였으며, 이로 인해 국민의 의료 보장성 강화 및 비용 부담을 경감시키는데 기여하였다.

* 리소좀축적병 선별검사 관행가 금액 396억 추정→등재금액* 179억원: 국민
의료비 절감액 약 217억

* 등재금액 = 등재금액(검토당시 1회 비용: 상대가치점수x병의원 점수당 단가x
다빈도 중별가산율)

○ 또한, 말기 신부전 환자에게 대체행위가 없는 투석행위를 신의료기술평가와
보험등재를 동시에 진행*함으로써 신부전 환자의 삶의 질이 향상되었으며
의료비 부담도 감소하였다.

* 동시진행으로 인한 처리기간 단축((350→280일, 70일↓)

○ '22년에 이어 '23년에는 분만, 심혈관·뇌혈관질환의 필수의료분야를 우선 등재
추진할 것을 계획하고 있다.